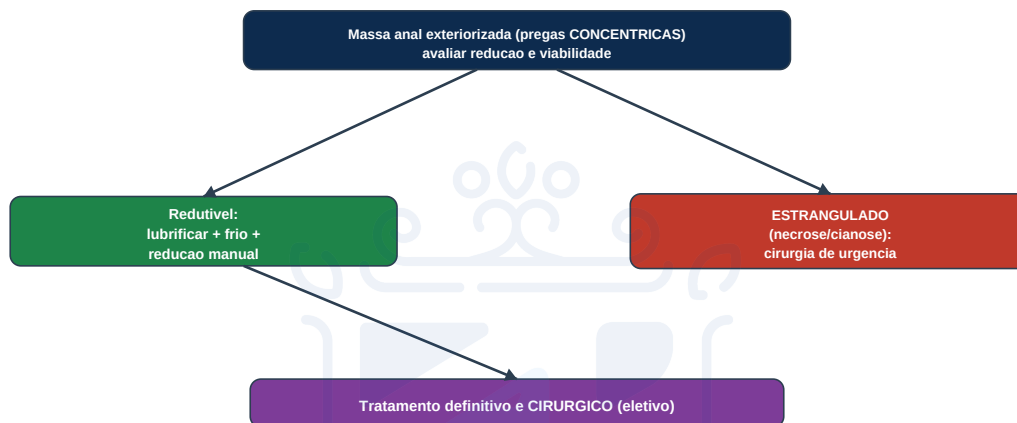


PROLAPSO RETAL — REDUZIR + CIRURGIA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

PROLAPSO RETAL — REDUZIR x ESTRANGULADO



DEFINIÇÃO E FISIOPATOLOGIA

O QUE É

- Exteriorização do reto pelo canal anal: COMPLETO (espessura total, cilíndrico/concêntrico, idosos) ou MUCOSO (pregas radiais, associado a hemorroidas)
- Multifatorial: fraqueza do assoalho pélvico, alongamento do ligamento reto-sacral, ângulo anorretal obtuso, hipotonia esfinteriana, constipação crônica/esforço, neuropatia pudenda (idosas multiparas)
- Clínica: massa anal exteriorizada, sensação de peso, INCONTINÊNCIA fecal (frequente), secreção mucosa, sangramento, constipação paradoxal
- DOR sugere ESTRANGULAMENTO
- Dica: pregas CONCÊNTRICAS = prolapso completo; pregas RADIAIS = hemorroidas

DIAGNÓSTICO

CLÍNICO + COMPLEMENTAR

- Clínico (inspeção anal); manobra de Valsalva em posição ortostática para evidenciar o prolapso
- Colonoscopia: EXCLUIR neoplasia (sobretudo em idosos) antes da cirurgia eletiva
- Defecografia em casos complexos; manometria anorretal para planejamento cirúrgico
- RM pélvica se associação com outras disfunções do assoalho pélvico
- Diferenciais: hemorroidas internas prolapsadas, prolapso mucoso, tumor anal, intussuscepção retal interna

CONDUTA NO PS — REDUÇÃO

Rx PROLAPSO REDUTÍVEL

Lubrificação abundante + compressas frias + elevação da pelve (Trendelenburg)
Redução manual delicada e progressiva
Se edema importante: aplicar AÇÚCAR granulado ou compressa hipertônica sobre a mucosa por 20-30 min (reduz o edema osmoticamente) e então reduzir
Analgesia para conforto durante a manobra
Após redução, encaminhar para programação cirúrgica eletiva

EMERGÊNCIA — PROLAPSO ESTRANGULADO

NÃO REDUZ / ISQUEMIA

- Sinais: dor intensa, edema importante, cianose/necrose, irreducibilidade
- Conduta: analgesia + antibioticoprofilaxia + avaliação cirúrgica IMEDIATA + cirurgia de urgência
- Não insistir em reduzir mucosa francamente necrótica
- Risco de perfuração/sepsis se negligenciado
- Encaminhamento prioritário ao cirurgião

TRATAMENTO DEFINITIVO (CIRÚRGICO)

Abordagem	Indicação / técnicas
Abdominal (preferida se bom risco)	Retopexia ± ressecção sigmoide (aberta/laparoscópica); menor recorrência, melhor continência; jovens/bom estado
Perineal (idosos/frágeis)	Delorme (prolapso curto), Altemeier/retossigmoidectomia perineal (prolapso longo); menor risco anestésico, maior recorrência
Pós-operatório	Controle rigoroso da constipação (fibras + laxativo osmótico), fisioterapia do assoalho pélvico, avaliar continência

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com prolapso retal ____ (completo/mucoso); redutível: ____; dor/cianose (estrangulado?): ____.
- Incontinência ____; comorbidades/risco anestésico ____; neoplasia excluída (colono): ____.
- Conduta no PS: redução ____ (lubrificação/açúcar/Trendelenburg), analgesia; antibiótico se estrangulado.
- Encaminhamento à cirurgia: eletiva (retopexia/Delorme/Altemeier) OU URGENTE se estrangulado.

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Como diferenciar, à inspeção, o prolapso retal completo das hemorroidas prolapsadas?

- A) Prolapso completo tem pregas radiais; hemorroidas, concêntricas
- B) Prolapso completo tem pregas CONCÊNTRICAS; hemorroidas, pregas RADIAIS
- C) Não há diferença ao exame
- D) Hemorroidas nunca sangram
- E) Prolapso nunca causa incontinência

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Idoso com prolapso retal edemaciado, redutível, sem necrose. Qual conduta no PS?

- A) Cirurgia de urgência imediata
- B) Lubrificação, compressas frias/açúcar granulado para reduzir o edema e redução manual delicada
- C) Apenas analgesia e alta
- D) Antibiótico oral por 14 dias
- E) Colostomia de urgência

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Quais sinais indicam prolapso retal estrangulado (emergência cirúrgica)?

- A) Massa indolor e redutível
- B) Dor intensa, edema importante, cianose/necrose e irreducibilidade
- C) Apenas secreção mucosa
- D) Incontinência isolada
- E) Sangramento mínimo

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é o tratamento definitivo do prolapso retal completo?

- A) Clínico com laxativos isolados
- B) Cirúrgico (retopexia abdominal ou cirurgia perineal — Delorme/Altemeier)
- C) Banho de assento
- D) Antibiótico
- E) Dieta apenas

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Antes da cirurgia eletiva de prolapso retal em idoso, qual exame é importante?

- A) Endoscopia digestiva alta
- B) Colonoscopia para excluir neoplasia
- C) Ecocardiograma de rotina
- D) Cintilografia óssea
- E) Nenhum exame é necessário

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O prolapso retal completo mostra pregas **CONCÊNTRICAS** (cilíndrico), enquanto as hemorroidas prolapsadas têm pregas **RADIAIS** — diferença prática essencial ao exame.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

No prolapso redutível com edema, lubrifica-se, aplicam-se compressas frias ou açúcar granulado/compressa hipertônica (reduz o edema por osmose) e faz-se a redução manual delicada, encaminhando depois para cirurgia eletiva.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Dor intensa, edema importante, cianose/necrose e irreducibilidade indicam estrangulamento — emergência que requer analgesia, antibioticoprofilaxia e cirurgia de urgência.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O tratamento definitivo é cirúrgico: abordagem abdominal (retopexia ± ressecção, preferida em bom risco) ou perineal (Delorme/Altemeier, em idosos/frágeis).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A colonoscopia é importante antes da cirurgia eletiva, especialmente em idosos, para excluir neoplasia colorretal associada.

SM24
Suporte ao Plantão Médico